



● Президія

Підсумки підбито, плани накреслено



6 березня відбулась президія Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України.

Серед важливих організаційних та фінансових питань діяльності обласної профспілки у 2025 році, члени президії заслухали доповідь головного технічного інспектора Олени Журавльової про стан охорони праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності в закладах охорони здоров'я у 2024 році.

Зокрема, інспектор наголосила, що впродовж 2024 року у закладах охорони здоров'я, що входять до Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України, сталося 14 нещасних випадків з них 3 із смертельним наслідком.

За участі головного технічного інспектора праці було проведено 4 розслідування. Протягом року у закладах охорони здоров'я постійно проводилась консультаційна, роз'яснювальна робота, своєчасно, відповідно до змін та нововведень надсилались інформаційні листи на електронні адреси закладів охорони здоров'я, надавались відповіді на кожне звернення членів профспілки, розроблявся план протипожежних заходів та надзвичайних ситуацій.

Члени профспілки привітали нового члена президії Юрія ГОЛИКА, який цього року очолив профспілкову організацію Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

● До перемоги разом

Не зупиняємо допомогу Збройним Силам України!

Нещодавно Львівська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я України знову передала до військової частини черговий РЕБ та побажала нашим воїнам здоров'я, успіху та якнайшорішої Перемоги.

Варто наголосити, що Львівська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я у період воєнного часу, окрім своєї основної, постійно займається організацією волонтерської роботи спрямованої на підтримку та надання допомоги медичним працівникам, які постраждали внаслідок агресії РФ проти України, біженцям й тимчасово переселеним з інших областей України, які потребують медичної та соціальної допомоги.

Надається фінансова благодійна допомога обласним організаціям на території, де відбуваються бойові дії, так в травні 2023 року після теракту на Каховській ГЕС була зібрана та перерахована на рахунок Херсонської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я благодійна допомога в розмірі 250 тис. грн. Луганській обласній організації 50 тис. грн та іншим.

Також в умовах війни з російським агресором робота

обласної організації була зосереджена і на наданні конкретної допомоги Збройним Силам України. В жовтні 2022 року Львівська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я України придбала та передала для потреб медиків Збройним силам України автомобіль Mercedes-Benz вартістю 199 тис.грн

В травні 2023 року було придбано та передано військовій частині Збройних сил України автомобіль марки Volkswagen Transporter вартістю 216 тис.грн.

В червні 2023 року придбано та передано Збройним силам України квадрокоптер (дрон) DJI Mavic 3 вартістю 100 тис.грн

В жовтні 2023 року придбано та передано медикам військової частини Міністерства оборони України автоматичний гематологічний аналізатор Abacus Junior 30 вартістю 235 тис.грн.

На потреби військових медиків як благодійна допомога була передана партія хімічних реактивів, які необхідні для швидкого та повноцінного аналізу крові з використанням гематологічного аналізатора.

У 2024 році надана допомога збройним силам України в розмірі 948 тис. грн, а саме:

– 2 квадрокоптери на суму 390 тис. грн;



– 3 виробу радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Намет-Ф-12», «Намет-Ф-24» на суму 288 тис. грн, (РЕБ) «Намет-Д» вартістю 264 тис. грн.

В лютому 2025 року придбано 1 виріб радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Намет-Д» вартістю 264 тис. грн.

Ми переможемо разом!

Новини медицини

У Центрі протезування та реабілітації Superhumans Lviv українські та іноземні військово-вслужбовці, а також цивільні, які зазнали поранень і травм внаслідок повномасштабної війни, можуть, зокрема, займатись у спеціальному басейні. Це дає можливість значно урізноманітнити комплекс вправ до, під час та вже після протезування.

За потреби, до басейну можна занурити навіть спеціальну бігову доріжку чи велотренажер, які є в Центрі. Також одним натиском кнопки можна запустити симулятор течії: сильний струмінь під водою дозволяє пацієнтові плисти ніби проти стрімкої гірської річки, що дозволяє збільшити навантаження. Ну а після занять на вибір пацієнтів – три гідромасажери, подібні до джакузі. Вони дозволяють розслабити напружені м'язи.

Басейн обладнаний рейковою системою підтримки пацієнта, що кріпиться до стелі над басейном. Окрім цього, під час занять гідротерапією пацієнти можуть: покращити дихальну функцію організму завдяки гідростатичному тиску води; підвищити витривалість.

Чехія виділить майже 30 мільйонів євро на ремонт відділень у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Ю. Липи. З них 13 мільйонів – грантові гроші, а 17 мільйонів – кредитні.

Чехія фінансово допоможе з ремонтом відділень у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Загальна сума допомоги становить понад 30 мільйонів євро: близько 13 мільйонів у вигляді грантів і майже 17 – у кредитних коштах. Гроші надійдуть в межах чеської програми «Renovation and modernization of hospitals in Ukraine».

ТРЦ «Forum Lviv» передав сучасні безтіньові хірургічні лампи для лікарні «ОХМАТДИТ».

Центр дитячої медицини. Лікарня «Охматдит» отримала новітні безтіньові хірургічні лампи EM-LED5+5, які забезпечать ще більшу точність та комфорт під час операцій. Це стало можливим завдяки благодійній ініціативі торгово-розв'язального центру «Forum Lviv» у співпраці з БФ «Здорові діти»

та активної участі відвідувачів ТРЦ. Спільними зусиллями вдалося зібрати 230 000 грн, що дозволило придбати необхідне обладнання для операційного відділення лікарні.

Об'єднання поліклінік у Львові: на сесії підтримали рішення про реорганізацію. Першу та шосту міські поліклініки Львова об'єднують в одну. Таке рішення ухвалили депутати Львівської міської ради. «За» проголосували 39 депутатів.

Відповідно до рішення депутатів міської ради Львова першу поліклініку зліквідують. Її правонаступником стане шоста поліклініка.

3 1 березня 2025 року зміняться правила ціноутворення на ліки, вони мають подешевшати.

У переліку медпрепаратів, що подешевшають, є ліки, що їх використовують при кашлі та застудах, антигістамінні, протизапальні препарати, вітаміни, а також ліки проти тиску, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї. Ціни будуть знижені на різні відсотки, починаючи від 10% і закінчуючи зниження до 52% на антидепресанти, які коштують 220 гривень, також зараз на 46% планують знизити ціну на всім відомий валідол, який зараз коштує 13 гривень і є доступним для пацієнта.

● Презентація



4 березня 2025 р. на конференції профспілкової організації КНП "Буська ЦРЛ" головою організації була обрана КОНЦ Христина Михайлівна. Сьогодні представляємо вам, шановні читачі, новобрану голову.

– Христіно Михайлівно, Львівська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я щиро вітає Вас з обранням і бажає плідної праці на благо людей.

– Дякую і розумію, що медичні працівники – це опора суспільства, яка, працюючи в напружених умовах, щодня рятує життя. Захист і підтримка медиків є пріоритетом для всіх професійних об'єднань і, звичайно, також і для нашої профспілки. Окрім забезпечення належних умов праці, зарплат і соціальних гарантій, профспілки мають сприяти оздоровленню, відпочинку та гармонійному розвитку своїх членів. Вважаю, що однією з ключових сфер діяльності має стати організація якісного дозвілля, спорту та відпочинку як для медиків, так і для їхніх членів сім'ї.

Христина КОНЦ: «Турбота про медиків – це турбота про здоров'я всього суспільства»



– Для початку розкажіть про свій шлях у медицину, хто Ви за фахом, скільки працюєте у лікарні й, зокрема, скільки часу Ви – у профспілці.

– За фахом я лікар епідеміолог. Навчалася у Львівському національному університеті ім. Данила Галицького на медичному факультеті. У 2007-2013 рр. – пройшла інтернатуру за спеціалізацією епідеміологія. У Буській лікарні працюю уже 2 роки. В профспілку вступила одразу. Тож і в профспілці я також два роки.

– Якою зараз є організація, яку Вам довірили очолювати? Яка її чисельність, які заходи в активах, як оздоровлюються діти, словом, що доброго було зроблено?

– Чисельність нашої профспілки 520 людей.

Здоров'я медиків – це їхня професійна необхідність, тому оздоровлення було чи найпершою метою профспілкових ініціатив. У 2024 році оздоровилось троє працівників, які відпочивали у санаторії Вілла "Марта". Звичайно, порівняно з

кількістю членів профспілки, це – дуже мало.

Завдячуючи обланій профспілці, наші медики завжди – навіть в умовах війни – відзначають своє професійне свято. До дня медичного працівника було організовано поїздку у святе місце - Зарваницю, у якій взяли участь 84 члени профспілки.

– Що плануєте на перспективу, можливо, щось змінити, додати?

– Медична сфера вимагає величезної фізичної та емоційної віддачі, що часто призводить до вигорання. Тому, вважаю, що профспілка має забезпечувати доступ до санаторіїв та баз відпочинку. Буду підтримувати тісні стосунки із Львівською обласною організацією профспілки медиків, яка, знаю, вже уклала договори з оздоровчими санаторіями, частково покриваючи витрати на відпочинок.

Планую також тематичні тури та екскурсії – організовувати поїздки в місця спокою для зняття стресу – стає популярний місцевий зелений туризм. Хотіла б приділити увагу релаксаційній програмі – запроваджувати його чи медитаційні хвилини. Над цим і планую працювати.

Профспілка має не лише відстоювати права своїх членів, а й дбати про їхнє фізичне та емоційне здоров'я. Організація відпочинку, спортивних заходів і дозвілля для дітей – це ефективний шлях до покращення якості життя медичних працівників. Турбота про медиків – це турбота про здоров'я всього суспільства.

– Чи має профспілка підтримку і розуміння адміністрації?

– Профспілка має дружні стосунки з адміністрацією. Тісно співпрацюємо і плануємо розпочати роботу над проектом нового колективного договору.

– Успіхів Вам у роботі.

● Співпраця по-новому

Фермери Львівщини – медикам!

Перша в Україні Автокрамниця фермерських продуктів вперше приїхала до медиків

«Фермерську родину» запросила профспілкова організація Центру легеневого здоров'я. Для працівників та пацієнтів Центру фермери радо організували дегустацію та продаж екологічно чистих продуктів, які виробляють самі і які привезли до фтизіологів власною Автокрамницею.

– Проведена акція викликала інтерес. Це справді важливо, щоб на столі тих, хто лікує, була якісна, натуральна їжа, – каже генеральний директор Центру легеневого здоров'я Любомир Рак.

– Цей захід ми організовуємо у неробочий час, зручний для обох сторін. До нас фермери приїжджали уже двічі. Є багато позитивних відгуків, особливо про молочні продукти – продукція фермерів потроху змінює уявлення про натуральні смаки. – долучається до розмови голова профспілки Наталя Багрило.



Історія кооперативу "Фермерська родина" почалася у складний час пандемії COVID-19. Саме тоді фермери Львівщини, котрі з любов'ю та турботою виготовляють та вирощують свіжі та якісні продукти, й організувалися в кооператив. Основною метою стало спільне просування продукції та забезпечення ефективного маркетингу. Тоді в кооператив вступило 20 учасників, Тепер є вже – 36.

Відтоді фермери втілюють у життя багато проектів. Один з них – Львівський фермерський ярмарок, який діє з травня до жовтня на пл.Ринку. Ярмарок дозволяє львів'янам регулярно купувати все найсвіжіше, якісне і зроблене з любов'ю. Продукти фермерів не бувають у промислових масштабах, не залежуються на складах, не задихаються під поліетиленом. До речі, фермери задекларували свої екологічні цілі, серед яких відмова від хімічної упаковки, система повернення тари, компостування органічних відходів, підтримка біорозмаїття.

Кооператив втілює у життя ще й такий цікавий проект. Торік на вул. Кн. Ольги усю зиму за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» працював Хаб популяризації продукції локальних виробників. Співорганізаторами цього проекту була «Фермерська родина». А

Що чекає медиків в Автокрамниці?

Крафтові свіжі та якісні фермерські продукти: уся молочна та м'ясна лінійка, овочі, фрукти, соуси, мед, хліб, випічка, вина, соки, мікрогрін, сублімація, чіпси, снеки. Продукти можна замовити попередньо (https://www.instagram.com/farm_rodyna/) і отримати на локації.



нещодавно кооператив отримав фінансову підтримку від уряду Канади, що дозволило придбати автомобіль для унікальної крамниці «на колесах», яка й стала першою в Україні мобільною торговою точкою, що доставляє продукцію безпосередньо до споживачів. Уже і клієнти є: IT-компанії, заводи та свідомі споживачі, які цінують натуральні продукти. А їх ще й заздалегідь можна замовити на сайті.

– Уявіть, що ви куштуєте сир, який визрівав під наглядом сировара, м'ясо, виготовлене за давніми фермерськими традиціями, та вино, що зберігає характер місцевих виноградників. Це не просто продукти – це історії, які вам розкажуть ті, хто їх створює. Кооператив «Фермерська родина», зібрав унікальну добірку локальних делікатесів, яких не знайдете в супермаркетах – запевняє голова кооперативу Наталя Табінська.

● Інформує відділ правової роботи Львівської обласної організації профспілки

Хто у закладі охорони здоров'я має подати щорічну декларацію?

Традиційно до 31 березня 2025 року (включно) триває щорічна кампанія з антикорупційного декларування за період 2024 року. Тож нагадуємо, хто серед працівників закладів охорони здоров'я належить до суб'єктів декларування.

За загальним правилом, відповідно до частин 1 та 2 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (надалі - декларація) подають особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а», «в»-«г» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зокрема посадові особи юридичної особи публічного права.

До юридичних осіб публічного права відносяться державні та комунальні заклади охорони здоров'я. Водночас до посадових осіб юридичної особи публічного права належать: голова та член наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), ліквідатор, керівник, заступник керівника, головний бухгалтер, корпоративний секретар такої юридичної особи публічного права, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники, голова та члени іншого органу управління юридичної особи (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом юридичної особи публічного права.

Разом з тим у частині 5 статті 45 Закону передбачені винятки у частині застосування вимог з фінансового контролю. Зокрема, вимоги щодо подання декларації не поширюються на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері охорони здоров'я (крім керівників закладів охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня, голів та членів експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи та військово-лікарських комісій). Зазначена пільгова норма стосується також тих закладів охорони здоров'я, які діють в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства.

Отже, обов'язок щодо подання декларації у закладі охорони здоров'я мають лише:

- керівники закладів охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення) рівня;
- голови та члени експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи;
- голови та члени військово-лікарських комісій.
- голови та члени МСЕК, у тому числі особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням повноважень голови або члена МСЕК.

Натомість не належать до суб'єктів декларування, зокрема: заступники керівника ЗОЗ; головний бухгалтер ЗОЗ; керівники структурних підрозділів ЗОЗ; голови та члени лікарсько-консультативних комісій.

Чи стає особа суб'єктом декларування у разі тимчасового виконання обов'язків службової чи посадової особи? На думку Національного агентства з питань запобігання корупції, якщо особа виконує обов'язки за вакантною посадою, на неї поширюються всі вимоги Закону саме за цією посадою, крім вимог, передбачених ч. 3 ст. 46, ч. 4 ст. 52, ст. 56 Закону. Вакантною є посада, зазначена у штатному розписі відповідного органу, організації, установи або підприємства, на яку не укладено договір / не призначено особу безстроково без укладення договору. Тривалість виконання обов'язків у цьому випадку не має значення. При цьому, якщо особу призначають виконуючою обов'язки директора ЗОЗ на вакантну посаду, вона у цьому випадку стає суб'єктом декларування (при умові якщо згідно з законом керівник цього ЗОЗ є декларантом) з моменту призначення виконуючим обов'язки, і зобов'язана подавати всі види декларацій, крім декларації кандидата на посаду.

Натомість якщо особа виконує обов'язки за посадою, яка не є вакантною (тобто у зв'язку з відсутністю керівника, який / яка займає цю посаду і за яким / якою зберігається робоче місце та посада – відрядження, перебування на лікарняному тощо), вимоги щодо декларування на неї поширюються за фактично займаною нею посадою.

Рекомендуємо додатково ознайомитися із відповідними роз'ясненнями НАЗК (від 13.11.2023 №4 з наступними змінами й доповнення), що розміщені на сайті агентства у розділі «База знань». Зокрема, варто звернути увагу на питання № № 29, 30, 38, 39 цих роз'яснень.

Профспілка не погодила проєкт постанови Уряду

Профспілка працівників охорони здоров'я України в межах компетенції розглянула проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 р. № 28» (далі – проєкт постанови) та не погоджує його як такий, що погіршує умови оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу людям, які хворіють на туберкульоз, та не виконує норми частини першої статті 22 Закону України від 14.07.2023 № 3269-IX «Про подолання туберкульозу в Україні» (далі – Закон № 3269).

Згідно з Пояснювальною запискою проєкт постанови розроблено на виконання Плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Закону № 3269.

Частиною першою статті 22 Закону № 3269 встановлено, що працівникам регіональних фтизіопульмонологічних центрів, які надають медичну допомогу людям, які хворіють на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за людьми, які хворіють на туберкульоз, та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі люди, встановлюються підвищені посадові оклади у зв'язку зі шкідливими й важкими умовами праці, надбавка за вислугу років та інші надбавки й доплати. Перелік робіт, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на підвищені посадові оклади, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Водночас Законом № 3269 встановлено, що умови та розміри оплати праці працівників регіональних фтизіопульмонологічних центрів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Проєктом постанови пропонується доповнити вступну частину постанови Кабінету Міністрів України від 13.01.2023 № 28 «Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я» словами «статті 22 Закону України «Про подолання туберкульозу в Україні», а також визнати такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 123 «Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз» (зі змінами) (далі – постанова №123).

Положеннями постанови № 123 з метою забезпечення підвищення престижності праці за роботу в особливих, важких та шкідливих умовах праці встановлено підвищення посадових окладів працівникам, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз в спеціалізованих закладах охорони здоров'я та їхніх структурних підрозділах на 30% (активна форма туберкульозу) та на 60% (заразна форма).

На думку Профспілки, скасування постанови № 123 без прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нового рішення про умови та розміри оплати праці працівників регіональних фтизіопульмонологічних центрів є невиконанням вимог частини першої статті 22 Закону № 3269 щодо забезпечення на державному рівні гарантій із підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу людям, які хворіють на туберкульоз, і призведе до погіршення, у порівнянні з чинними, умов та розмірів оплати праці таких працівників та спровокує труднощі із залученням кваліфікованих медичних кадрів до роботи в особливих, специфічних шкідливих і важких умовах праці.

З огляду на вищезазначене та з метою безумовного виконання завдань та рішень, необхідних для забезпечення реалізації Закону № 3269 в частині підвищення престижності праці працівників регіональних фтизіопульмонологічних центрів, які надають медичну допомогу людям, які хворіють на туберкульоз, та забезпечення державних гарантій в оплаті їхньої праці у важких та шкідливих умовах, пропонуємо провести узгоджувальну нараду з цих питань за участю всіх зацікавлених сторін та Профспілки.

Вікторія КОВАЛЬ, Голова Профспілки

Розпочала роботу електронна система рейтингового розподілу в інтернатуру

У системі: збиратиметься та аналізуватиметься успішність випускників закладів вищої освіти, проводитиметься автоматизований рейтинговий розподіл в інтернатуру, здійснюватиметься електронний супровід усього процесу підготовки інтернів, формуватимуться електронні документи щодо проходження інтернатури.

Система виключає можливість зовнішнього втручання у процес рейтингового розподілу до інтернатури та впливу на його результати та робить його абсолютно прозорим. Вона інтегрована до єдиного порталу вакансій у медзакладах, тож інтерни проходитимуть практичну частину підготовки за обраною спеціальністю на посадах, яких реально потребують заклади охорони здоров'я.

Цьогоріч розподіл в інтернатуру відбуватиметься серед усіх випускників закладів вищої медичної й фармацевтичної освіти з урахуванням автоматизованого розрахунку рейтингового балу.

Рейтинговий бал формуватиметься з чотирьох показників: КРОК-1 або КРОК Б (20% балу), КРОК-2 (40%), ОСКІ (20%), середній бал випускника за всі роки навчання (20%).

Розрахунок відбуватиметься з точністю до 0,00001.

Випускник-медик вперше зможе обрати бажане місце за спеціальністю з усіх наданих місць для державного розподілу в межах цілої країни. Перший розподіл в системі відбудеться уже 17 березня 2025 року для випускників зі спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» («Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія») чотирьох медичних закладів:

Запорізького, державного медико-фармацевтичного університету, Харківського національного медичного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Основний же розподіл відбудеться у червні-липні. Система створена на Платформі Дія. Engine за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку реалізує Фонд Східна Європа.

Зміни до ДКХПП

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 7.03.2025 № 419 внесено зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», затвердженого наказом МОЗ України від 29 березня 2002 року № 117 (ДКХПП), якими, зокрема, запроваджені такі нововведення:

Кваліфікаційна характеристика посади «Начальник (завідувач, керівник) структурного підрозділу закладу охорони здоров'я» (пункт 13 розділу «Керівники» ДКХПП) доповнена положеннями наступного змісту: «застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих в межах спеціальності, яка відповідає профілю структурного підрозділу, надає їм екстрену (невідкладну) медичну допомогу». По суті, зазначені зміни дозволили завідувачу відділення закладу охорони здоров'я в межах своєї посади безпосередньо надавати медичну допомогу пацієнтам. Раніше, згідно з ДКПП, до компетенції завідувача як керівника належали організація лікувально-профілактичної та адміністративно-господарської діяльності підрозділу, співпраці з іншими підрозділами закладу охорони здоров'я.

ДКХПП доповнений новою кваліфікаційною характеристикою посади «Професіонал з клінічних досліджень» (пунктом 31 Підрозділу «Інші професіонали в галузі медицини» розділу «Професіонали»).

Кваліфікаційна характеристика посади «Лікар-інтерн» викладена у новій редакції (пункт 17 розділу «Фахівці» ДКХПП)

ДКХПП доповнено новою кваліфікаційною характеристикою посади «Лікар-резидент» (пункт 58 розділу «Фахівці» ДКХПП).

Чи потрібно для продовження безоплатної відпустки (згідно з п.3 ст.12 Закону України №2136), після продовження дії воєнного стану, писати нову заяву?

Так. Відповідно до частини 3 статті 26 Закону України «Про відпустки», на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, визначеного ч. 1 цієї статті. Тривалість такої відпустки визначається угодою сторін.

Підставою для оформлення зазначеної відпустки є заява від працівника про надання відпустки без збереження заробітної плати, погоджена керівником установи. В заяві зазначається вид відпустки, підстава та підтвердження для її надання, дата початку та закінчення, тривалість відпустки. У преамбулі наказу зазначається підстава: норма відповідного закону та заява (для відпустки за ініціативою працівника). У наказі зазначаються ті ж самі відомості, що й у заяві, і додатково вказується дата виходу працівника на роботу.

Таким чином, у разі продовження дії воєнного стану, яка затверджується новим нормативним актом, змінюється як підстава надання відпустки, так і її можлива тривалість, що потребує видання нового наказу, а відповідно і написання нової заяви.

Джерело:
Держпраці/Східне міжрегіональне управління

● До 211 річниці українського Пророка

**І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.**

Тарас ШЕВЧЕНКО



Життя Шевченка з погляду лікаря

Шевченківські березневі дні особливі для українців. Ми у цей час, як і заповідав Тарас Григорович Шевченко, обов'язково згадуємо нашого Пророка, Великого Кобзаря й Українського Генія. Прошло 211 років від його народження, проте кожного разу перед нами відкриваються нові грані його творчості, його життя. Тож сьогодні наша розмова – з погляду лікаря

Писати про Тараса Григоровича Шевченка дуже складно. Передусім тому, що про нього багато написано й сказано. Шевченко прожив 47 років, з яких 24 – в кріпацтві, 10 років – на заслання й лише 13 років був вільним. Офіційні документи й свідчення людей, що добре знали Шевченка, стверджують, що він був міцної будови тіла, середнього зросту, плечистий, проте не збереглося жодного опису стану здоров'я Шевченка. Тому його недуги доводиться відтворювати на ґрунті автобіографічних даних, на підставі того, що оповідав про себе сам Шевченко.

Першу важку хворобу Шевченко переніс у Петербурзі на весні 1837 року, у 23 роки, перед тим, як був викуплений з кріпацтва. Про цю недугу згадує сам Шевченко в повісті «Художник». Лікувався в міській лікарні св. Марії Магдалини (нині лікарня ім. Віри Слуцької), вісім днів був без свідомості, а потім ще два тижні гарячував. На дошпитальному етапі, вдома, оглядав поета лікар Олексій Сергійович Жидовцев, а в лікарні – Олександр Дмитрович Бланк (дід Леніна по матері).

Після викупу з кріпацтва 22.04. 1838 р., як учень К. Брюллова, поет почав відвідувати Академію мистецтв, слухав лекції в університеті, медико-хірургічній академії та вільному економічному товаристві. Лекції з пластичної анатомії в медико-хірургічній академії читав професор Ілля Васильович Буяльський (з Чернігівщини).

Восени 1839 р., у віці 26 років, Тарас Шевченко захворів на тиф. Тоді ж він малює олійними фарбами автопортрет, на якому видно прояви хвороби – худорляве обличчя, великі запалі очі, загострений ніс, на лиці позначені сліди хвороби.

У 1842 році Тарас Григорович вирушив у морську подорож до Копенгагена і Стокгольма, яка дала Шевченкові багато нових вражень і розвинула його творчу енергію. Подорож закінчилась нещасливо для здоров'я поета, він важко захворів, зате з'явився один із шедеврів першого періоду його творчості – поема «Гамалія».

Повернувшись в Петербург, поет написав своєму приятелю в Харків: «Мене носив проклятутий парохід у Шведчину і Датчину. Пливши в Стокгольм, я скомпонував Гамалія, невеличку поему, та так занедужав, що ледве привезли мене в Ревель, там трошки очунав... Хоч лікар і говорить, що «нічево», однак так киває головою, що аж сумно дивитися... А, лебедику, як не хочеться кидать землю, хоч вона й погана! А треба буде, хоч воно ще й рано. Молю тільки милосердного Бога, щоб поміг мені весни діждати, щоб умерти на Україні».

Морське колювання Шевченко зносив легко, бо пізніше ніколи не нарікав на морську хворобу, а причиною тяжкої хвороби була, мабуть, застуда.

У березні 1845 року Шевченко завершив навчання в Академії. Рада Академії надала йому звання «вільного художника» і, не чекаючи видачі атестата, поет поїхав в Україну.

24 грудня 1845 року Тарас Григорович Шевченко важко захворів і його перевозять із с. В'юнища до Переяслава на лікування до лікаря Андрія Осиповича Козачковського. Їхнє знайомство відбулося ще восени 1841 року, коли останній навчався Петербурзькій медико-хірургічній академії. В Переяславі Козачковський був місцевим лікарем і викладачем медицини у Переяславській семінарії. В 1847 році в Орському укріпленні Шевченко пише присвяту «А. О. Козачковському».

Під час важкої хвороби 25 грудня 1845 року Шевченко пише свій знаменитий «Заповіт». Восени 1847 року в Орській фортеці він захворів на ревматизм. У листі до А.І. Лизогуба від 11 грудня 1847 р. поет пише: «Бодай і ворогові моєму лютому не довелося так каратись, як я тепер караюсь. І до того всього ще й треба було занедужать, восени мучив мене ревматизм». Того ж року, 20 грудня, вже в листі до М.М.Лазаревського поет повідомляє: «...опріч недуги, що в серце впилося, мов люта гадина, опріч всіх лих, що душу катують, – Бог покарав мене ще й тілесним недугом, занедужав я спершу ревматизмом, тяжкий недуг, та я все-таки потроху

боровся з ним і лікар, спасибі йому, трохи помагав». До того ж у цей час поет страждав і цингою.

Влітку 1850 р. Тарас Григорович захворів на хворобу очей, його спіткала сліпота. Лікарі, які надавали допомогу поетові у заслання: Олександрійський Михайло Семенович, родом з Чернігівщини; Колишко Антон Іванович, лікар Оренбурзького корпусу; Кількевич Сильвестр Станіславович, старший лікар Раїмського укріплення; Майдель Петро Євстахович, лікар Оренбурзької прикордонної комісії (брав участь у ліквідації епідемії холери в Оренбурзі 1848 р., Шевченко написав про це вірш «Чума»); Нікольський Сергій Родіонович, батальйонний лікар у Новопетровську; Лавров А., лікар місцевого лазарету, який лікував поета, коли його мучив головний біль.

Арешт, утримання у в'язниці під час слідства, великий емоційний стрес, а ще різка зміна клімату при перевезенні його до Петербурга і подальше відбування покарання в Оренбурзькому краю згубно вплинули на організм поета і сприяли виникненню хвороби.

Можна думати, що в цей час Шевченка турбували болі в ділянці серця, а ще одночасно сприймалися як туга за Україною, рідними, друзями та за улюбленим заняттям.

У 1855 році Шевченко захворів на малярію. Лікував його лікар Лебедев Олександр Михайлович, ординатор Новопетрівського госпіталю. 21 липня 1857 року Шевченка звільнили із заслання і після триденної подорожі морем він прибув до Астрахані, де замешкав на квартирі разом з лікарем Муравським Г., молодшим лікарем 45-го флотського екіпажу, який брав участь в обороні Севастополя. 20 вересня 1857 року поет прибув у Нижній Новгород. Був уже хворий. Лікар Гортвіг Осип Андрійович оглянув його і підтвердив захворювання. Це врятувало поета від повернення в Оренбург.

Протягом цього часу Шевченко познайомився з лікарями Кебером Г., Рейковським І., Малоюго А. Отримавши дозвіл на проживання в Петербурзі, поет вирушив у дорогу, проте у дорозі застудився, зупинився в Москві, у свого близького друга – актора Михайла Щепкіна, теж викупленого колись з кріпацтва. В цей час поетом опікувалися лікарі Ван-Путерен, Кетчер, а також Дмитро Мин, поет і медик, який став згодом одним із кращих московських гігієністів, завідувачем кафедри судової медицини й ректором Московського університету.

Прибувши до Петербурга, Шевченко зупинився в будинку Академії мистецтв. Художник Ковальов В.В., відвідавши Шевченка у той час, згадував: «Я був вражений різкою зміною його зовнішності: це вже був не той широкоплечий, кремезний, руський чоловік у сірому сюртуці, яким я знав його колись, переді мною був зовсім схудлий лисий чоловік, без кровинки на обличчі, руки його просвічувалися так, що видно було наскрізь кістки й жили... Я мало не заплакав».

Влітку 1859 року Шевченко повернувся в Україну, прибув до Переяслава і зупинився у лікаря Козачківського А.О. На автопортреті, намальованому в 1960 році, на обличчі поета помітні ознаки набряклості, що свідчать про тяжку хворобу серця. У листопаді 1960 року Шевченко звернувся до лікаря Едуарда Барі, ординатора Петербурзької лікарні св. Марії Магдалини, зі скаргою на сильний біль у грудях, а в кінці грудня 1860 року, уже зовсім хворий поет, з наказу лікаря, мусів засісти у своїй майстерні й примиритися з ув'язненням.

Шевченко писав про це своякові Варфоломію: «Погано я зустрів оцей новий поганий рік. Другий тиждень не виходжу з хати: чхаю та кашляю, аж обісіло», а через тиждень уже признався йому, що зовсім ослаб: «Так мені погано, що ледве перо в руках держу, і кат його батька знає, коли воно полегшає».

Останні місяці життя Т.Г. Шевченка лікував Круневич Павло Адамович. До слова, він закінчив Московський університет, і за антидержавні настрої був покараний солдат-

чиною та засланий в окремії Оренбурзький корпус. На новий 1861 рік Шевченко вже був прикутий до ліжка. Його розум постав перед фактом неминучості близького кінця, і він 14 лютого 1861 року пише свого останнього передсмертного вірша:

*Чи не покинуть нам, небого,
Моя сусідонько убога,
Вірші нікчемні віршувать
Та заходиться риштувать
Вози в далеку дорогу? –
На той світ, друже мій, до Бога
Почимчикуєм спочивать...*

Смерть неблаганно підступала до поета. Ще в жаклих умовах каторги-солдатчини він набув невеличкову хворобу серця і печінки як наслідок ревматизму, цинги й малярії.

У спогадах М. Лазаревського про останні дні життя Шевченка читаємо, що 25 лютого «застав його у страшних муках». За словами Тараса Григоровича, вночі у нього почався дуже сильний біль у грудях, що не давав йому лягти. Він сидів на ліжку і напружено дихав. Незабаром приїхав лікар Е. Барі. «...Вислухавши груди, лікар сказав, що водянка перекинулася у легені. Муки страдника були невимовні, кожне слово коштувало йому страшних зусиль. Мушка, накладена на груди, трохи полегшила страждання». Але це було ненадовго, далі читаємо: «Він сидів на ліжку, кожні п'ять-десять хвилин запитував, коли буде лікар, і висловлював бажання прийняти опій, щоб заснути». О шостій годині приїхав лікар П. Круневич. Хворий був у важкому стані. Він ледве відповідав на запитання лікаря і, здавалося, уже усвідомлював безнадійність свого становища. Близько дев'ятої години знову приїхали лікарі П. Круневич та Е. Барі. «...Вони ще раз вислухали груди хворого, вода і далі наповнювала легені», що дало підставу визнати стан хворого безнадійним.

Удосвіта Тарас Григорович підвівся з ліжка, запалив свічку і, тримаючись стіни, вийшов з кімнати, спустився чавунними сходами, зупинився, похитнувся, скрикнув і важко впав на підлогу. Це сталося о 5.30 ранку 26 лютого 1861 р. (10 березня за новим стилем).

У лікарському свідоцтві про смерть написано: «Свидетельство. Копия сие о том, что Академик Тарас Шевченко, 47 лет от роду, давно уже одержим органическим расстройством печени и сердца (vitium organicum hepatis et cordis); в последнее время развилась водяная болезнь (Hydrops), от которой он умер сего 26 февраля. С. Петербург, февраля 26 числа 1861 года.

Подлинник подписал: доктор Эдуард Бари, ординатор при больнице Св. Марии Магдалины». Нижче помітка олівцем: «47 лет от рождения».

Про смерть поета Коломійченко М. та Гарленко В. зробили такий висновок: «Передсмертною хворобою Шевченка був органічний декомпенсований порок серця третього ступеня, цироз печінки і асцит». Коваленко П. припускає, що це була «мітральна хвороба серця» і, можливо, стеноз гирла аорти, як типові наслідки ревматизму.

Підсумовуючи ці відомості, можна поставити діагноз: хронічна ревматична хвороба серця, активна фаза, безперервно рецидивуючий ревмокардит. Комбінована вада серця із перевагою стенозу гирла аорти, недостатність мітрального клапана. Поліартрит. Кардіальний цироз печінки. Анасарка. Набряк легень.

Сучасна медицина, використовуючи наявні можливості та лікувальні засоби, звісно, продовжила б життя поета. Але йому судилося вічно жити у нашій пам'яті.



**Адам
МОКРИНСЬКИЙ,
лікар
з експертизи
тимчасової
непрацездатності,
лікар-отоларинголог
КНП “Золочівська
ЦРЛ”**